DESATURATION AU BLOC OPERATOIRE

Chez un PATIENT INTUBÉ

(dispositif supraglottique au verso)

CONFIRMER et VERIFIER

- ❑ Vérifier le signal de pulsoxymétrie (PNI, colorants,…)
- ❑ Mettre la FiO_2 à 1 et ouvrir le circuit
- ❑ Vérifier la ligne de prélèvement du capnographe
- ❑ Rechercher une défaillance hémodynamique

Informer l'équipe chirurgicale et **envisager la suspension de l'intervention**

Les procédures de vérification ne doivent pas retarder la prise en charge de **l'hypoxémie**

APPEL A L'AIDE

Tel …….

CAPNOGRAPHE ABSENT

- ❑ Vérifier :
  - branchement de capnographe
  - pression du ballonnet de la sonde
  - fonctionnalité du circuit patient et du respirateur
- ❑ Auscultation
- ❑ Evoquer bronchospasme sévère (contexte)

➡ **Tester la ventilation manuelle sur sonde au BAVU à FiO_2 1 avec oxygène de secours**

Ventilation **EFFICACE**

- ❑ identifier / corriger problème respirateur ou circuit (message sur l'écran alarmes)

Ventilation **INEFFICACE**

= Problème intubation

- ❑ Extubation accidentelle ?
- ❑ Intubation œsophagienne ?
- ❑ Obstruction complète ?

➡ **RE-INTUBATION**

CAPNOGRAPHE PRESENT et/ou ANORMAL

- ❑ Auscultation
- ❑ Analyse des courbes de spirométrie et pression

Auscultation asymétrique: discuter échographie pleuro-pulmonaire

- ➢ Intubation sélective ➡ Mobilisation
- ➢ Atéléctasie ➡ (fibro)aspiration / recrutement
- ➢ Épanchement pleural ➡ Drainage
- ➢ Pneumothorax ➡ Drainage

Auscultation symétrique et pressions élevées

- ➢ Désadaptation patient / machine
- ➢ Obstruction partielle de la sonde / morsure
- ➢ Bronchospasme

➡ Sédation, (fibro)aspiration, ré intubation, bronchodilatateurs

Auscultation symétrique et pressions normales:

- ➢ Embolie (gazeuse, fibrinocruorique, autre …)
- ➢ Cause cardiogénique (IDM, tamponnade …)
- ➢ Bas débit / hypovolémie (état de choc hémorragique, anaphylactique…)
- ➢ Résorption de colorant (bleu de méthylène…)

Réalisée en 2024 par le CAMR

DESATURATION AU BLOC OPERATOIRE

avec DISPOSITIF SUPRAGLOTTIQUE

(intubation au verso)

CONFIRMER et VERIFIER

- ❑ Vérifier le signal de pulsoxymètrie (PNI, colorants,…)
- ❑ Mettre la FiO2 à 1 et ouvrir le circuit
- ❑ Vérifier la ligne de prélèvement du capnographe
- ❑ Rechercher une défaillance hémodynamique

Informer l'équipe chirurgicale et **envisager la suspension de l'intervention**

Les procédures de vérification ne doivent pas retarder la prise en charge de **l'hypoxémie**

APPEL A L'AIDE

Tel …….

PRISE EN CHARGE

- ❑ Approfondir l'anesthésie
- ❑ Curariser le patient
- ❑ Si ballonnet, vérifier la pression
- ❑ Repositionner le dispositif supraglottique

En cas d'échec:

- ❑ Retirer le dispositif et ventiler au masque facial
- ➢ Ventilation **non efficace** ➡ Voir aide cognitive « patient non ventilable »
- ➢ Ventilation **efficace** ➡ **ENVISAGER L'INTUBATION** (si besoin voir au verso de cette fiche)

Référentiels: Operating Room Crisis Checklists (http://www.projectcheck.org/crisis-checklistsregistration.html)
https://sfar.org/wp-content/uploads/2018/10/2_RFE-CURARE-3.pdf

Réalisée en 2024 par le CAMR